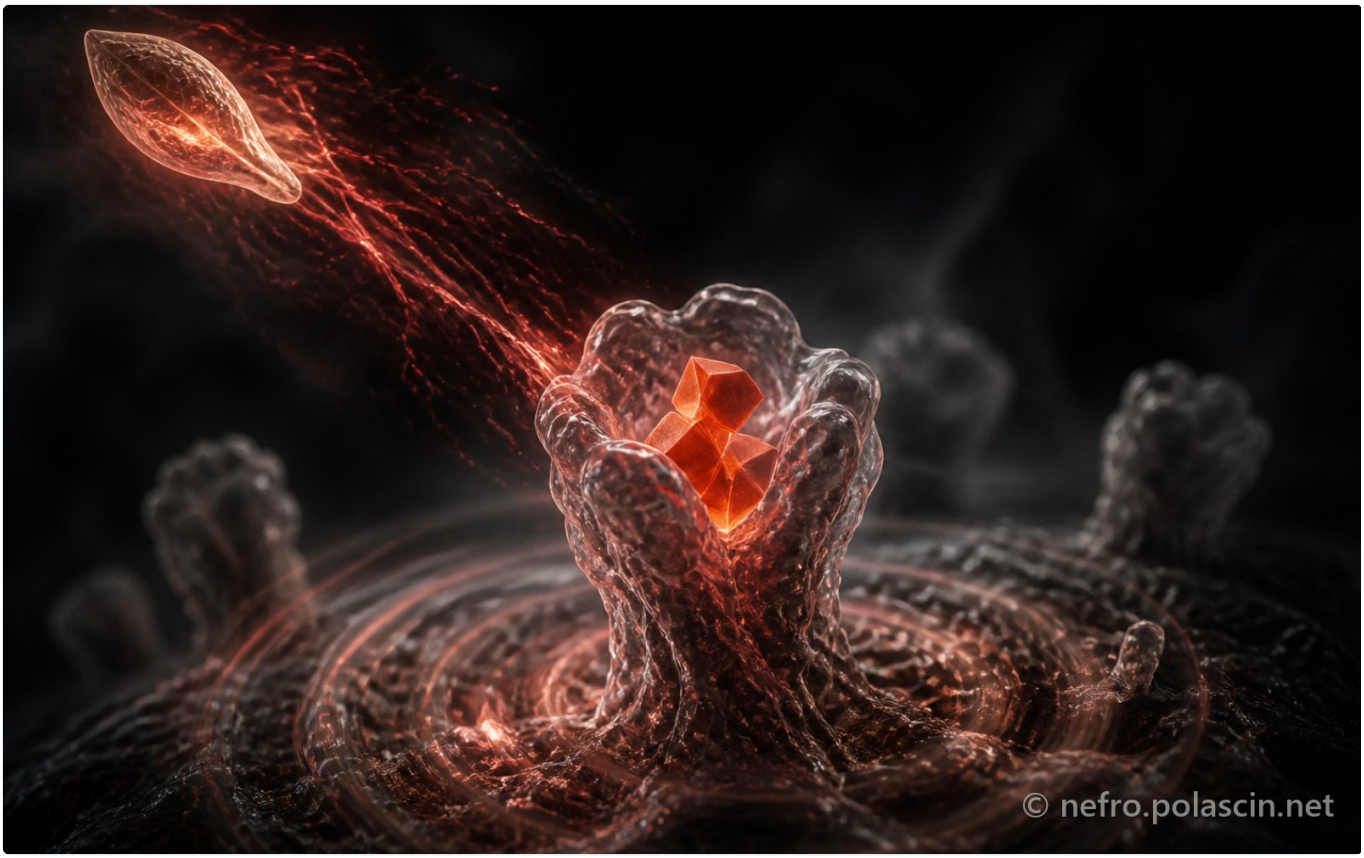
Ťažká abstinenčná reakcia po naltrexóne u užívateľa kratomu: kazuistika a jej poučenie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna vytesnenia agonistu z opioidného receptora antagonistom. Nejde o zobrazenie reálnej molekulárnej štruktúry ani o snímku konkrétneho pacienta.

Naltrexón je kompetitívny antagonista opioidných receptorov a pri liečbe závislosti od alkoholu patrí k štandardným možnostiam. Jeho bezpečné začatie má jednu dobre známu podmienku: pred podaním sa vyžaduje **obdobie 7 až 10 dní bez opioidov**, inak môže vyvolať nebezpečnú precipitovanú abstinenciu.

Kazuistika uverejnená 21. októbra 2026 v časopise *Federal Practitioner* opisuje, čo sa stane, keď je opioidnou aktivitou niečo, čo za opioid nikto nepovažuje. Informácie o lieku kratom ako výstrahu neuvádzajú a bežné toxikologické vyšetrenie moču ho nezachytí.

Kratom v skratke

Kratom (*Mitragyna speciosa*) je v Spojených štátoch neregulovaná, v niektorých štátoch nezákonná rastlinná látka so stimulačným a analgetickým účinkom. Obsahuje viac než 40 alkaloidov; mitragynín a 7-hydroxymitragynín majú od dávky závislú afinitu k μ aj κ opioidným receptorom.

Dávkovo závislý je aj celý obraz. Pri nižších dávkach prevažuje stimulačný účinok, pravdepodobne cez serotonergné a adrenergné receptory; vyššie dávky vyvolávajú uvoľnenie dopamínu po aktivácii μ receptora a pocit eufórie. Na rozdiel od opioidov kratom nevyvoláva rutinne útlm dýchania, čo je jeden z dôvodov, prečo sa vníma ako neškodný.

Závislosť sa však vyvíja. V populačnej štúdii malo problémy so závislosťou až 55 % používateľov, pričom 65 % malo mierne a 35 % stredne ťažké až ťažké abstinenčné príznaky. Patria k nim nepokoj, nekľud, tremor, hnačka, potenie, zívanie, výtok z nosa a baženie.

Epidemiologicky nejde o okrajový jav. V prierezovom prieskume v rámci National Survey on Drug Use and Health užilo kratom za uplynulý rok odhadom 0,7 % populácie, ale medzi ľuďmi s poruchou užívania opioidov to

bolo 10,4 %. Medzi rokmi 2011 a 2017 bolo americkým toxikologickým centrám hlásených 1 807 expozícií kratomu; 31,8 % viedlo k hospitalizácii a zaznamenaných bolo 11 úmrtí.

Prípad

Šesťdesiatštyriročný muž s hmotnosťou 65 kg bol zaradený do multidisciplinárneho programu pre ukončenie užívania alkoholu. Uvádzal pitie počas posledných štyroch rokov, naposledy približne 8 uncí liehu denne, ráno a večer. V anamnéze mal veľkú depresívnu poruchu, artériovú hypertenziu a chronickú bolesť chrbta, pre ktorú v minulosti užíval opioidy; posledných desať rokov podľa svojich slov nie. Chronicky užíval metoprolol, famotidín, tamsulozín, mirtazapín, lizinopril a kyselinu listovú.

Pri vstupnom vyšetrení bol **eutýmny**, spolupracujúci, orientovaný osobou, miestom, časom aj situáciou, s logickým a cieleným myslením. Toxikologické vyšetrenie moču bolo negatívne na fencyklidín, benzodiazepíny, kokaín, amfetamíny, kanabinoidy, opiáty, barbituráty a metadón. Dostal predpis na naltrexón 25 mg denne a kontrolu o týždeň.

Prvú dávku užil večer. **Do jednej hodiny** sa stal mimoriadne nepokojným a povedal: „Niečo nie je v poriadku, zavolajte záchranku.“ Spočiatku bol pri ťažkej úzkosti ešte spolupracujúci a sám si nastúpil do sanitky. Počas prevozu sa nepokoj zhoršil a dostal diazepam intravenózne.

Na urgentnom príjme mal tachykardiu 118/min, tachypnoe 22/min a tlak 189/121 mm Hg. Bol orientovaný miestom a osobou, nie však situáciou. V diferenciálnej diagnostike boli zvažované pečeňová encefalopatia, odvykací stav pri alkohole, akútna intoxikácia a nežiaduci účinok lieku.

Počas nasledujúcich hodín sa stal spoteným, nespolupracujúcim a agresívnym a vytrhol si intravenózne kanyly. Pre nepokoj **refraktérny na benzodiazepíny** bol intubovaný na zaistenie dýchacích ciest.

Opakované toxikologické vyšetrenie moču bolo negatívne, hladina alkoholu v sére 147 mg/dl, amoniak 56 µmol/l, vyšetrenie moču bez odchýlok a počítačová tomografia hlavy bez prínosu. Z laboratórnych nálezov bola odchýlkou len mierna transaminitída.

Až pri ďalšom rozhovore s rodinou vyšlo najavo, že pacient desať rokov pravidelne užíval kratom v prášku, jednu čajovú lyžičku trikrát denne rozmiešanú v horúcej vode, teda približne **6,0 až 7,5 g denne**. Manželka vysvetlila, že s kratomom začal, aby zvládol abstinenčné príznaky po opioidoch.

Pacient bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti s minimálnymi parametrami ventilácie a liečený podľa protokolu pre odvykací stav pri alkohole vrátane parenterálneho tiamínu. Dostával benzodiazepíny a titrovateľné infúzie opioidov, propofolu a dexmedetomidínu. Pre horúčku 38,8 °C dostal empirické antibiotiká, zdroj infekcie sa však nezistil (hemokultúry aj vírusový panel negatívne). Na druhý deň sa objavili vodnaté stolice. Extubovaný bol na siedmy deň, pre následnú slabosť potreboval rehabilitáciu a na dvanásty deň bol prepustený do intenzívneho ambulantného programu.

Prečo je príčinná súvislosť pravdepodobná

Autori uvádzajú ako najpravdepodobnejšiu diagnózu akútnu abstinenčnú reakciu na kratom vyvolanú naltrexónom. Podporujú ju:

- časová väzba do jednej hodiny od prvej dávky,
- desaťročné pravidelné užívanie kratomu v dávke nad prahom rizika,
- negatívne toxikologické vyšetrenie moču pri dvoch odberoch,
- žiadne nové serotonergné lieky a žiadny zistený zdroj infekcie,
- prítomnosť alkoholu v sére pri obraze, ktorý zodpovedal skôr odvykaciemu stavu než intoxikácii, a **refraktérnosť počiatočných príznakov voči benzodiazepínom**, čo svedčí proti čistému odvykaciemu stavu pri alkohole,
- absencia predchádzajúcej hospitalizácie pre látkové alebo psychiatrické ochorenie a podľa manželky žiadna predchádzajúca psychotická epizóda.

Skóre podľa Naranja bolo **5**, čo zodpovedá kategórii pravdepodobnej príčinnej súvislosti. Nasledujúci odvykací stav pri alkohole a potreba sedácie predĺžili čas na ventilátore.

Prečo sa to prehliadne

Podľa autorov sú v literatúre známe len **tri** prípady abstinenčných príznakov po prvej dávke naltrexónu u používateľov kratomu. Predchádzajúce prípady opisovali mierne príznaky; tento opisuje potenciálne ťažký následok s predĺženou hospitalizáciou.

Spoločným znakom všetkých hlásených prípadov je náhly nástup abstinenčných príznakov do jednej hodiny od podania naltrexónu, negatívne toxikologické vyšetrenie moču a návšteva urgentného príjmu. V troch zo známych prípadov sa užívanie kratomu zistilo až po začatí ťažkostí.

Dôvodov, prečo sa to prehliadne, je niekoľko a všetky sú odstrániteľné:

- **Pacient o kratome sám nepovie.** Buď pre stigmu, alebo pre presvedčenie, že ide o bezpečnú a nepodstatnú bylinnú látku, čo podľa autorov do veľkej miery formuje marketing.
- **Bežné toxikologické vyšetrenia kratom nezachytia.** Testy na mitragynín v moči existujú, ale v zdravotníckych zariadeniach nemusia byť dostupné.
- **Informácie o lieku neobsahujú výstrahu.** Kratom nie je v informáciách o naltrexóne uvedený ako upozornenie ani opatrenie a liekové databázy túto kombináciu neuvádzajú ako interakciu kategórie X, ako by to urobili pri opioidoch.

Rizikovými faktormi abstinenčnej reakcie sú vyššie dávky, orientačne od 6 g denne, a dlhodobé užívanie, hoci údaje z dobrovoľných prieskumov sú veľmi premenlivé a variabilita komerčných výrobkov presné kvantifikovanie sťažuje. Vyššie riziko môžu mať aj osoby s predchádzajúcou závislosťou od opioidov, čo bol presne tento prípad.

Čo z toho platí v nefrológii

Kratom nie je typicky nefrologická téma, ale tri prepojenia sú vecné.

Orgánová toxicita. Pri kratome je opisované poškodenie pečene, čomu zodpovedá aj mierna transaminitída v tomto prípade. Opísaná je aj multiorgánová dysfunkcia: v kazuistike z *ACG Case Reports Journal* sa u 37-ročnej ženy po dlhodobom užívaní doplnkov s obsahom kratomu rozvinulo zmiešané hepatocelulárne a cholestatické akútne poškodenie pečene, **akútne poškodenie obličiek** a pankolitída. Ide o jednotlivé prípadové práce, takže úroveň dôkazu je zodpovedajúco nízka, ale pri nevysvetlenom akútnom poškodení obličiek s hepatálnym nálezom u užívateľa rastlinných doplnkov je to hypotéza, ktorú sa oplatí položiť.

Bolesť pri dialýze. Chronická bolesť je u dialyzovaných pacientov vysoko prevalentná a možnosti analgézie sú obmedzené: nesteroidové antiflogistiká sú problematické, opioidy sa pri zníženej eliminácii kumulujú. Prípravok, ktorý sa predáva ako prírodný, voľne dostupný a analgetický, je v takejto situácii nápadne príťažlivý. Je rozumné sa naň priamo opýtať.

Prenosná metodická lekcia. Najcennejšie na tejto kazuistike nie je samotná látka, ale princíp. Negatívne toxikologické vyšetrenie nevylučuje prítomnosť látky, ktorá sa netestuje. Rovnaká logika platí v nefrológii pri akútnej tubulointersticiálnej nefritíde z nehláseného doplnku výživy, pri nefropatii z nefrotoxickej rastliny alebo pri nevysvetlenej hyperkaliémii u pacienta užívajúceho bylinný prípravok. „Pacient nič neužíva“ znamená, že sa ho nikto nespýtal na to správne.

Čo z toho vyplýva pre prax

1. Pred predpísaním naltrexónu sa cielene opýtať na kratom, vrátane dávky, formy a dĺžky užívania. Všeobecná otázka na „drogy“ ani na „lieky“ nestačí; kratom pacient pod tieto pojmy nezaradí.
2. Pri akútnom nepokoji a odvykacom obraze do jednej hodiny po prvej dávke naltrexónu zaradiť kratom do diferenciálnej diagnostiky, najmä pri negatívnom toxikologickom skríningu.
3. Nepokoj refraktérny na benzodiazepíny u pacienta, u ktorého sa predpokladá odvykací stav pri alkohole, je dôvodom prehodnotiť diagnózu, nie len zvýšiť dávku.
4. Otázky formulovať konkrétne a bez hodnotenia: na rastlinné prípravky, doplnky výživy, „bylinkové“ analgetiká a prípravky kupované cez internet.

5. Pri podozrení pokračovať v manažmente podľa závažnosti stavu a miestnych protokolov; v tomto prípade bola potrebná kombinácia podporných a symptomatických postupov vrátane zaistenia dýchacích ciest.

Autori uvádzajú ešte jeden dôsledok, ktorý sa pri kazuistikách ľahko prehliadne. Pacient po tejto skúsenosti vyjadril zdráhavosť skúsiť naltrexón znovu. Ťažká precipitovaná abstinencia tak môže nepriaznivo ovplyvniť aj budúce pokusy o liečbu závislosti od alkoholu.

Upozornenie: *Text je určený zdravotníckym pracovníkom. Ide o opis jedného prípadu; kazuistika je najnižšou úrovňou klinického dôkazu a nedovoľuje odhadnúť, ako často sa opísaná reakcia vyskytuje. Text nenahrádza odborné vyšetrenie, individuálne posúdenie ani platné klinické odporúčania a súhrny charakteristických vlastností liekov. Dostupnosť a právny status kratomu sa v jednotlivých krajinách líšia.*

Literatúra

1. Cole Jennifer L., Pittman Leah B., Osborne Jomo C., Osinski Michael N. Severe Kratom Withdrawal Induced by Oral Naltrexone: A Case Report and Call for Increased Awareness. Federal Practitioner. 2026;43(10):390–393. DOI: 10.12788/fp.0763. Veterans Health Care System of the Ozarks, Fayetteville, Arkansas. Autori neuvádzajú konflikt záujmov. Celý text.

2. Jarka Christopher, Gregoire Kathryn. Precipitated withdrawal with kratom use following naltrexone administration. Mental Health Clinician. 2023;13(3):155–158. DOI: 10.9740/mhc.2023.06.155.

3. Jensen Austin, Truong Quyen, Jameson Michael a kolektív. Kratom-induced transaminitis with subsequent precipitated opioid withdrawal following naltrexone. Mental Health Clinician. 2021;11(3):220–224. DOI: 10.9740/mhc.2021.05.220.

4. Singh Darshan, Müller Christian, Vicknasingam Balasingam. Kratom (Mitragyna speciosa) dependence, withdrawal symptoms and craving in regular users. Drug and Alcohol Dependence. 2014;139:132–137. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2014.03.017.

5. Khan Muhammad Zarrar, Abou Saleh Mohannad, Alkhayyat Motasem, Roberts Daniel E., Lindenmeyer Christina C. Multiorgan Dysfunction Related to Kratom Ingestion. ACG Case Reports Journal. 2021;8(8):e00647. DOI: 10.14309/crj.0000000000000647. PubMed PMID 34476274.

6. Naranjo Claudio A., Busto Usoa, Sellers Edward M. a kolektív. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clinical Pharmacology and Therapeutics. 1981;30(2):239–245. DOI: 10.1038/clpt.1981.154.

Poznámka k dôkazom

Všetky klinické údaje prípadu vrátane dávkovania, laboratórnych hodnôt, časovej postupnosti, skóre podľa Naranja a údajov o epidemiológii a závislosti boli overené priamo v plnom texte kazuistiky na verejne prístupnej stránke zdroja, vrátane úplného autorského zoznamu, afiliácie, bibliografických údajov a vyhlásenia o konflikte záujmov. Informovaný súhlas bol podľa autorov získaný od manželky pacienta ako osoby splnomocnenej na zdravotnú starostlivosť. Bibliografické údaje ostatných citovaných prác boli prevzaté zo zoznamu literatúry primárnej kazuistiky; údaje o multiorgánovej dysfunkcii boli samostatne overené v zázname PubMed.

Vlastným prínosom tohto spracovania je prepočet dennej dávky kratomu voči uvádzanému prahu rizika 6 g denne, zdôraznenie refraktérnosti voči benzodiazepínom ako diagnostického vodidla, oprava prekladu klinického stavu pri vstupnom vyšetrení (eutýmny, nie eufórický) a nefrologická časť o multiorgánovej toxicite, o analgézii pri dialýze a o prenosnej metodickej lekcii, podľa ktorej negatívne toxikologické vyšetrenie nevylučuje netestovanú látku. Tieto súvislosti nie sú obsiahnuté v primárnej kazuistike.

Súvisiace články

- Konopa a riziko bipolárnej poruchy
- Postmarketingové bezpečnostné zlyhania liekov
- Biopsia obličiek pri glomerulárnych ochoreniach

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kratom-naltrexon-abstinencna-reakcia-kazuistika · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.